BÀI GIẢNG

THAI NGOÀI TỬ CUNG



BS. CKII. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO
BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Email: dangthaofr@gmail.com

MỤC TIÊU

1. Kể được các nguyên nhân TNTC
2. Mô tả triệu chứng TNTC
3. Trình bày hướng xử trí điều trị TNTC

I. ĐỊNH NGHĨA

Thai ngoài tử cung (TNTC) là trứng thụ tinh làm tổ và phát triển ở một vị trí ngoài buồng tử cung.

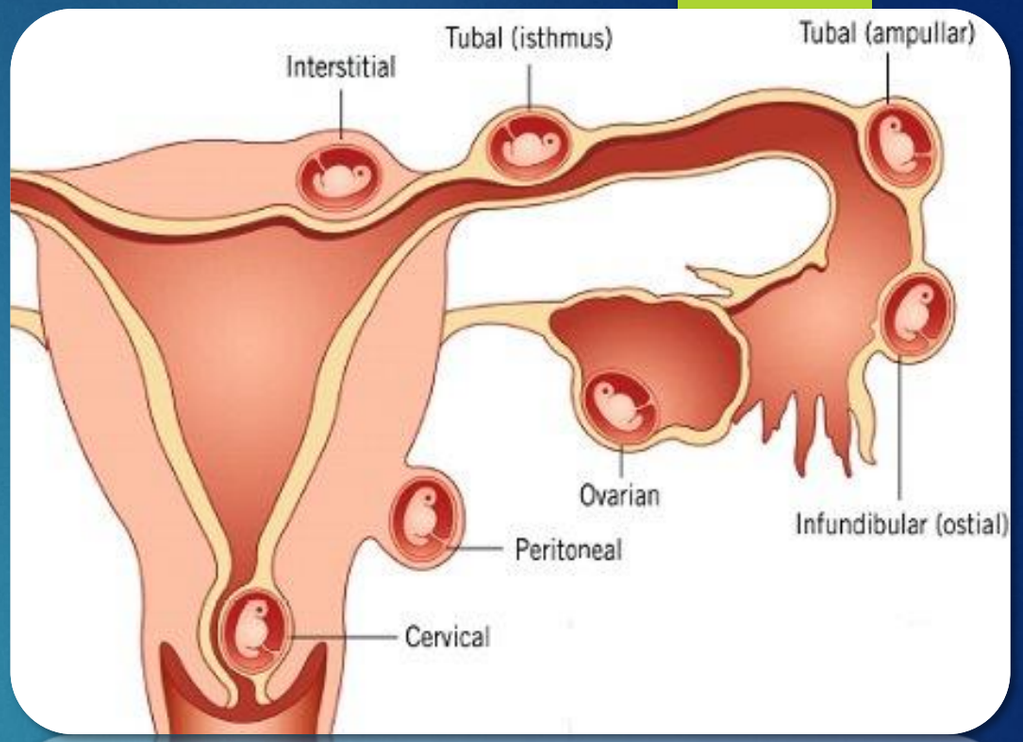
Tần suất:

-Chiếm khoảng 2% tổng số thai kỳ

-Khuynh hướng ngày càng tăng: 4.5% (1970) -> 19.7% (1992). Sự gia tăng này có liên quan mật thiết với sự tăng tần xuất mắc bệnh viêm vùng chậu, nạo hút thai, mổ lấy thai.

II. PHÂN LOẠI

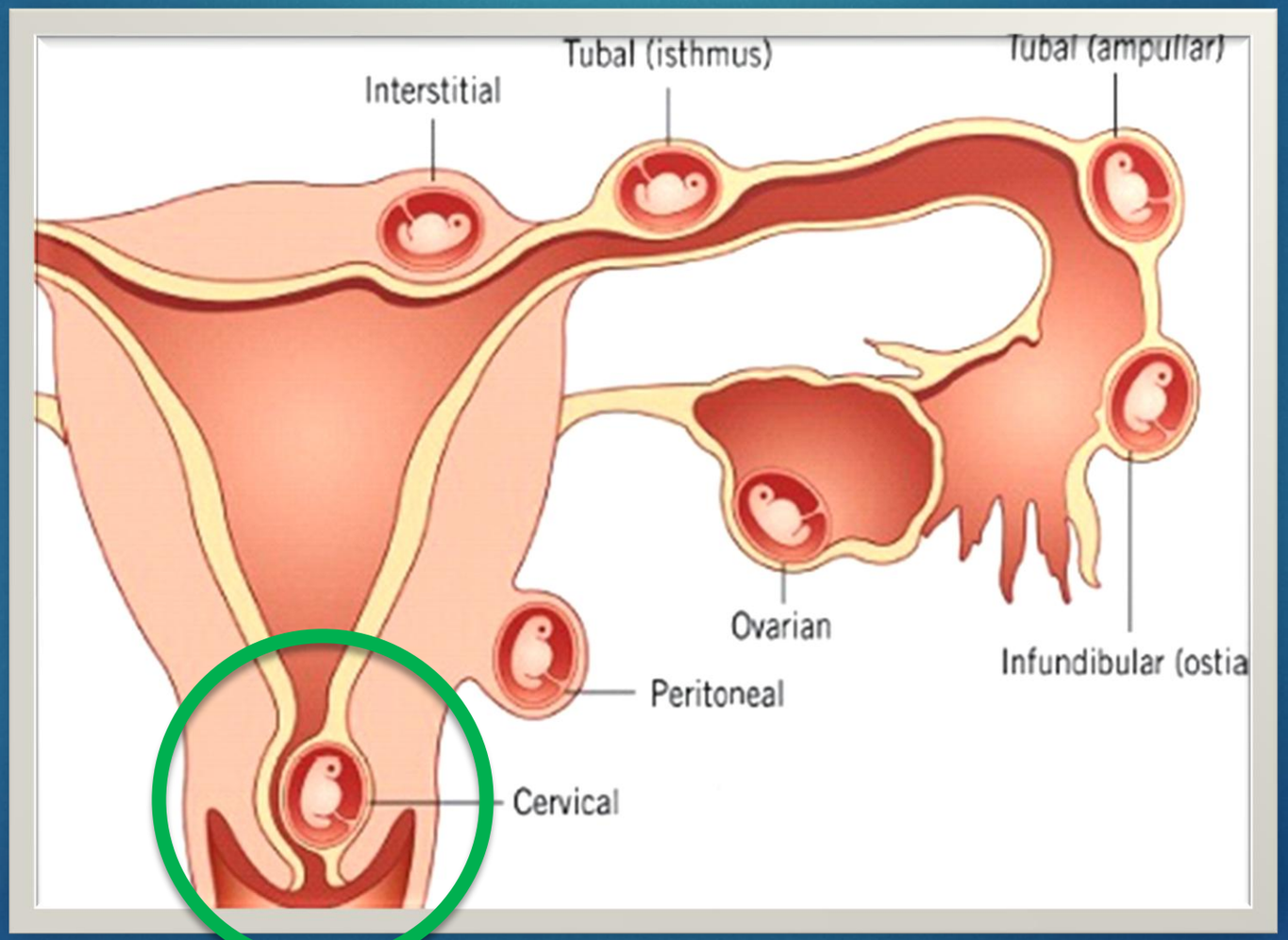
Các vị trí TNTC



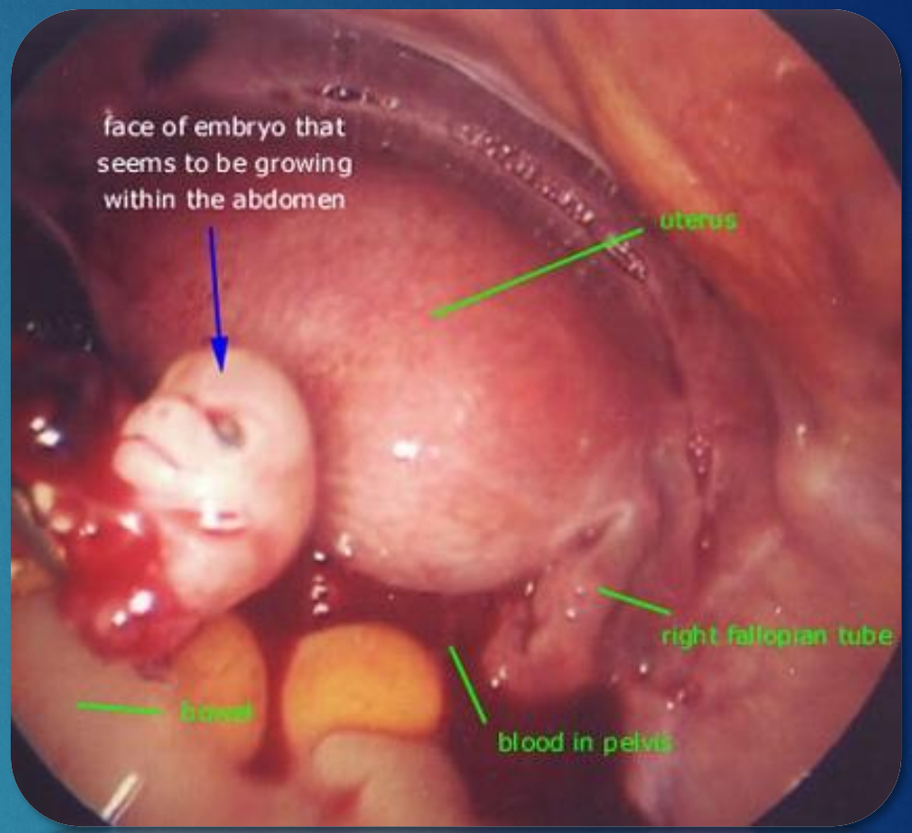
- Đoạn bóng vòi TC (80%): là phần tương đối rộng nên vỡ muộn

•Loa vòi (5%): khối thai phát triển gây rỉ máu qua loa tạo thành huyết tụ thành nang (HTTN)
•Đoạn eo vòi (12%)
•Đoạn kẻ (sừng) (2%): Đoạn này vỡ gây mất máu nặng
•Buồng trứng (0.5%)

- Cổ TC (0.45%): Thai làm tổ ở TC (#1/9000 ca sanh), có thể gặp trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (0.1%). Loại TNTC này có liên quan đến tiền sử nạo thai, mổ lấy thai



- Trong ổ bụng (0.1%): do thai bị sẩy qua loa, các gai nhau bám vào bề mặt các cơ quan trong ổ bụng và tiếp tục phát triển.Thai khó sống đến đủ tháng (trừ khi được cung cấp) đủ máu nuôi như ổ ruột, mạc treo ruột). Tử vong mẹ rất cao, vì khi bóc nhau không thể kiểm soát sự cầm máu nơi nhau bám



YẾU TỐ NGUY CƠ

1. **Viêm nhiễm** vùng chậu, viêm CTC do lậu hoặc Chlamydia trachomatis.
2. Tiền sử phẫu thuật vòi trứng: tái tạo vòi trứng, nối vòi trứng, tiền căn TNTC.
3. Bất thường cấu trúc giải phẫu của vòi trứng: polyp, túi thừa
4. Các kỹ thuật HTSS: kích thích rụng trứng, IVF



NGUYÊN NHÂN

- Do những yếu tố ngăn cản hay làm chậm trễ sự di chuyển của hợp tử từ nơi thụ tinh (thường là ở 1/3 ngoài của vòi trứng) vào đến buồng tử cung.
- Do tổn thương lớp bề mặt lông chuyển ống dẫn trứng (thường gặp viêm nhiễm Chlamydia trachomatis).

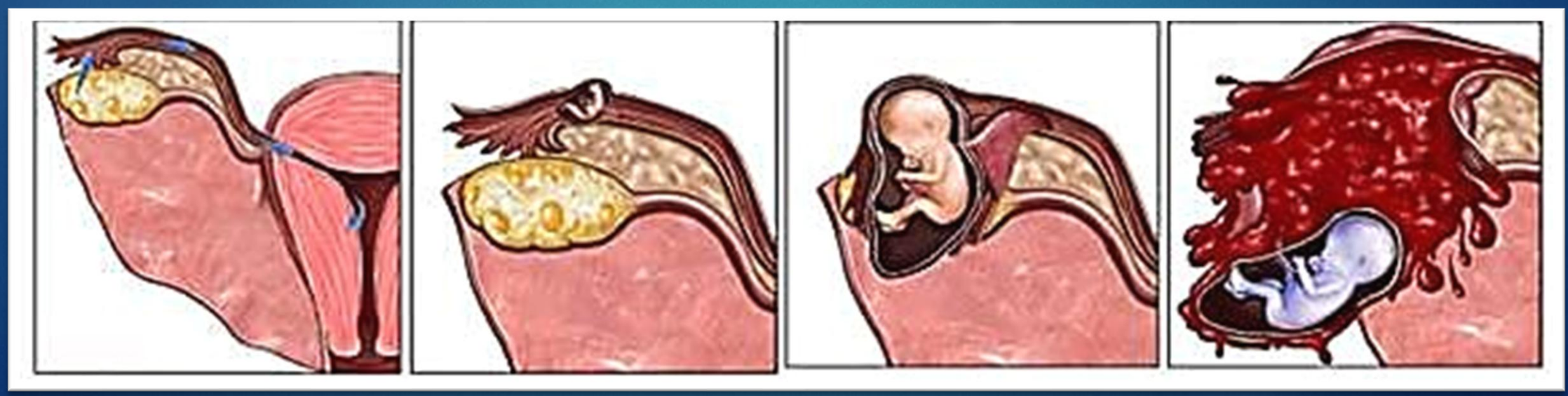
Cơ chế bệnh sinh

Vòi trứng

- Tổn thương nhung mao vòi TC
- Viêm -> tích tụ fibrin -> sẹo dính -> tắc nghẽn vòi

  + Hoàn toàn

  + Không hoàn toàn -> TNTC



IV. GIẢI PHẪU BỆNH

Vòi TC:

- Xuất huyết tạo khối máu tụ quanh khối thai -> to lên -> nứt tai vòi -> xuất huyết nội và rơi vào ổ bụng làm HTTN (huyết tụ trong thành nang)
- Tăng sinh tuyến nội mạc TC (phản ứng Arias – Stella) có thể thấy ở thai ngoài TC



V. LÂM SÀNG

1. TNTC chưa vỡ

- TCCN : trễ kinh, ra huyết rỉ, nâu đen. Đau bụng dưới âm ỉ, 1 bên.
- TC thực thể

Tổng trạng và dấu hiệu sinh tồn bình thường.

Bụng không căng hay căng nhẹ, có thể có phản ứng dội hoặc không.

MV : A Đ có ít máu đen chảy ra từ lỗ cổ TC. Cổ TC tím, khép kín.

Khám tay: cổ TC mềm, TC to hơn bình thường. Khối cạnh bên TC chạm vào đau (50%). Túi cùng sau trống.



V. LÂM SÀNG

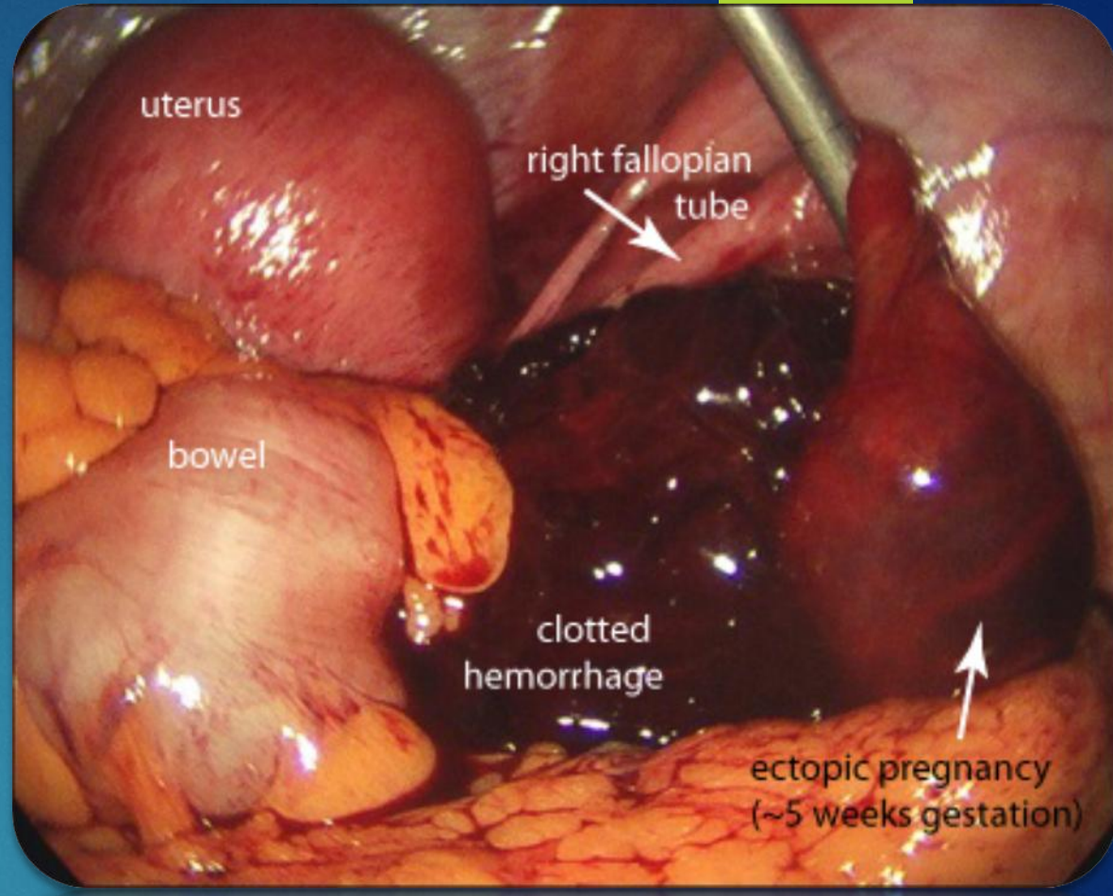
2. TNTC vỡ

- Triệu chứng cơ năng: trễ kinh, rong huyết, đau bụng dưới ngày càng tăng. Lúc TNTC vỡ, đau dữ dội như dao đâm, muốn ngất xỉu.



V. LÂM SÀNG

2. TNTC vỡ

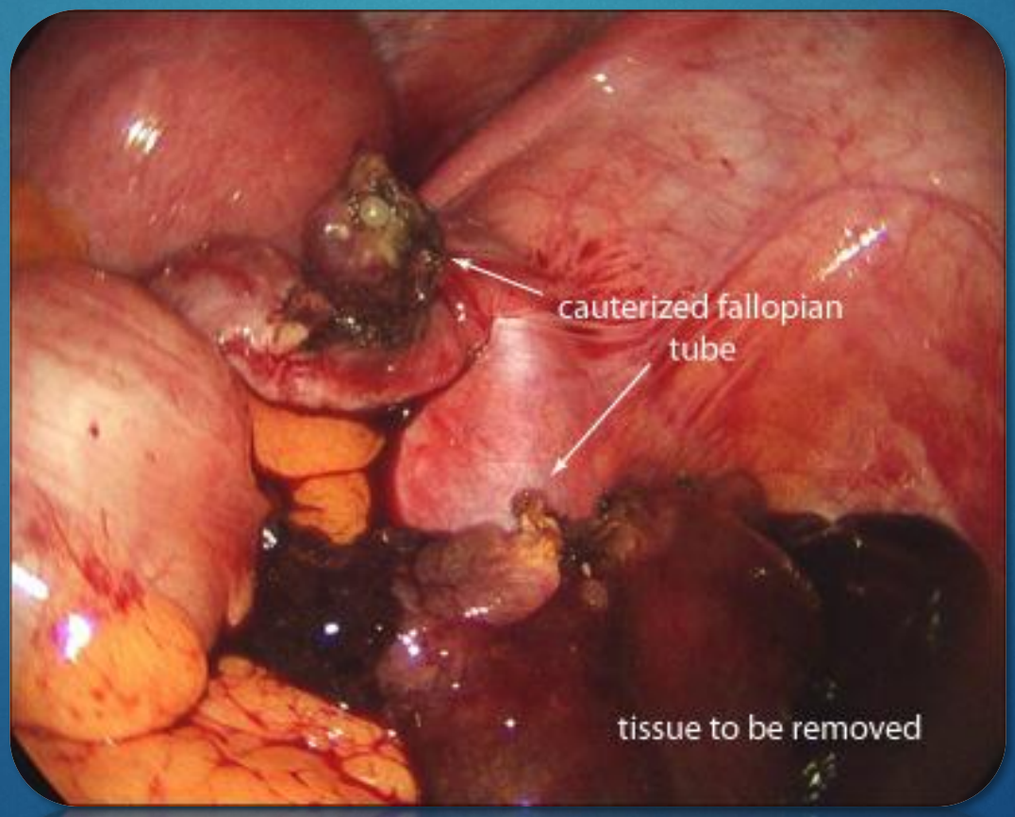


- Triệu chứng thực thể: Da xanh, viêm nhạt, vã mồ hôi, khát nước. Choáng do xuất huyết nội: mạch nhanh, HA tụt.
- Bụng phình, ấn đau, gõ đục vùng thấp.
- Khám Â. Đạo: cổ TC mềm, đóng, lay TC đau, 2 phần phụ khó xác định, do bệnh nhân gồng, túi cùng sau căng và rất đau khi khám.

V. LÂM SÀNG

3. Huyết tụ thành nang:

- Lâm sàng: tình trạng thiếu máu
- Thăm âm đạo: phát hiện 1 khối dính giới hạn không rõ ở cạnh TC hay sau TC, chạm đau.
- Siêu âm: khối phảm âm hỗn hợp cạnh TC
- ßHCG



V. LÂM SÀNG

4. Thai trong ổ bụng:

- Triệu chứng cơ năng:
  + Trể kinh, có triệu chứng nghén
  + Khi thai nhỏ: không có triệu chứng gì đặc biệt
  + Khi thai lớn: đau bụng mỗi khi thai cử động, rối loạn tiêu hoá.
  + Ra huyết Â. Đạo



- Triệu chứng thực thể:
  + Sờ thấy rõ thai qua da bụng
  + Ngôi thai bất thường
  + Khám Â. Đạo: TC kích thước bình thường, thai nằm ngoài TC

V. LÂM SÀNG

4. Thai trong ổ bụng:

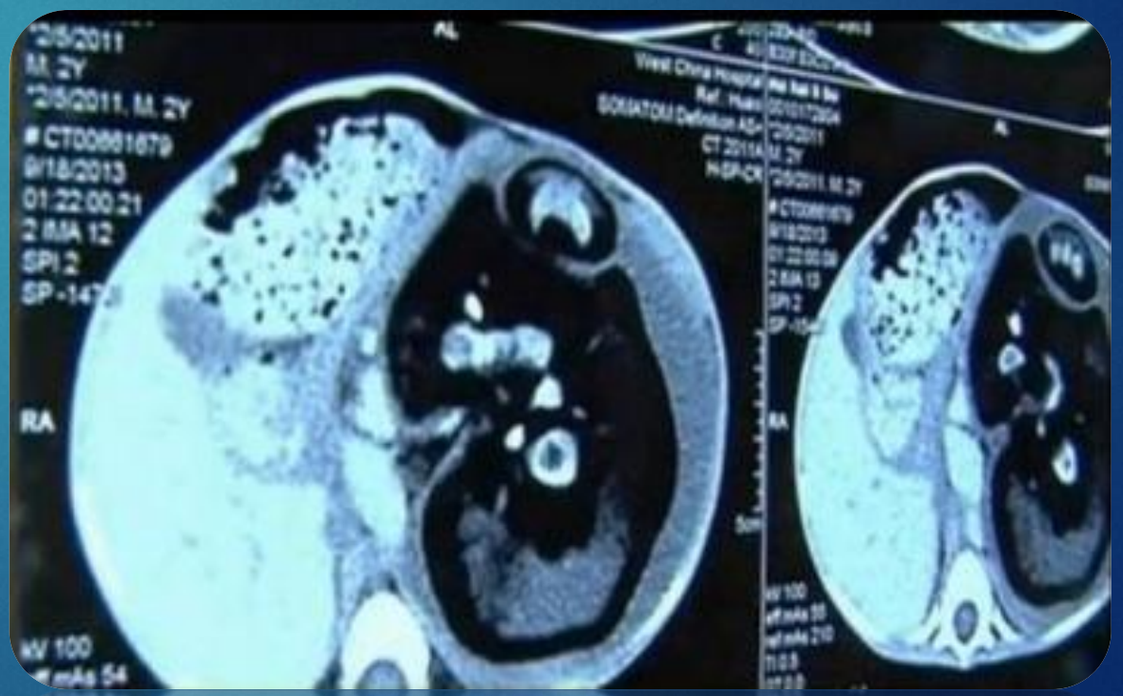
- Cận lâm sàng:

+ Siêu âm: TC trống. Không thấy thành TC bao quanh thai nhi. Thai nhi nằm trong ổ bụng xen giữa những quai ruột với vị trí bất thường

+ XQ: bụng không sữa soạn: thai năm vắt qua cột sống lưng mẹ

+ MRI: thai trong ổ bụng

+ Máu: AFP cao



V. LÂM SÀNG

5. Thai ở cổ TC: rất hiếm



- Thường sẩy trong 3 tháng đầu
- Nếu thai ở eo cổ TC -> khi nạo thường băng huyết nặng:

+ Triệu chứng cơ năng:

* Ra huyết Â. Đạo nhiều

* Đau bụng dưới quặn từng cơn (1/3 trường hợp)

+ Triệu chứng thực thể:

* Mỏ vịt: cổ TC mở, có tổ chức giống nhau thai -> dễ nhầm thai đang sẩy

* Khám tay Â. Đạo: đoạn dưới TC phình to (hình ảnh đồng hồ cát …..) . Lỗ ngoài cổ TC hé mở

* Siêu âm: cổ TC có khối máu tụ hoặc túi thai

* Doppler: tăng sinh mạch máu cổ TC (CĐ # thai đang sẩy)

VI. CẬN LÂM SÀNG

1. Định lượng ßHCG

- Chỉ cho biết có thai mà không chẩn đoán vị trí thai. Ngưỡng để phân biệt thai trong TC
- . Khi khám lâm sàng nghi ngờ một **thai kỳ bất thường**, lặp lại βhCG lần hai vào 2 ngày (48 -72h) sau đó để đánh giá nồng độ βhCG tăng hay giảm.
- Nồng độ βhCG tăng ≥ 66% sau 48 giờ cho một thai đang phát triển. Tuy nhiên, khoảng 15% trường hợp TNTC βhCG tăng < 53% sau 48 giờ và 17% trường hợp TNTC có βhCG tăng x 2 sau 48 giờ

VI. CẬN LÂM SÀNG

2. Siêu âm



- Là phương tiện chuẩn đoán rất quan trọng (đầu dò Â. đạo)
- Hình ảnh:
  + Không thấy thai trong lòng TC (+- túi thai giả)
  + Khối echo hôn hợp cạnh TC
  + Túi thai với phôi thai (+- sống) ngoài TC
  + Tụ dịch ở túi cùng sau hay dich trong ổ bụng khi TNTC đã vỡ
  + Nếu chưa rõ ràng thì hẹn SA lại 3 ngày sau.

3. XQ: dùng khi nghi ngờ thai trong ổ bung
4. Nạo sinh thiết buồng TC: dùng để chẩn đoán phân biệt thai trong TC và thai ngoài TC (không giữ thai)

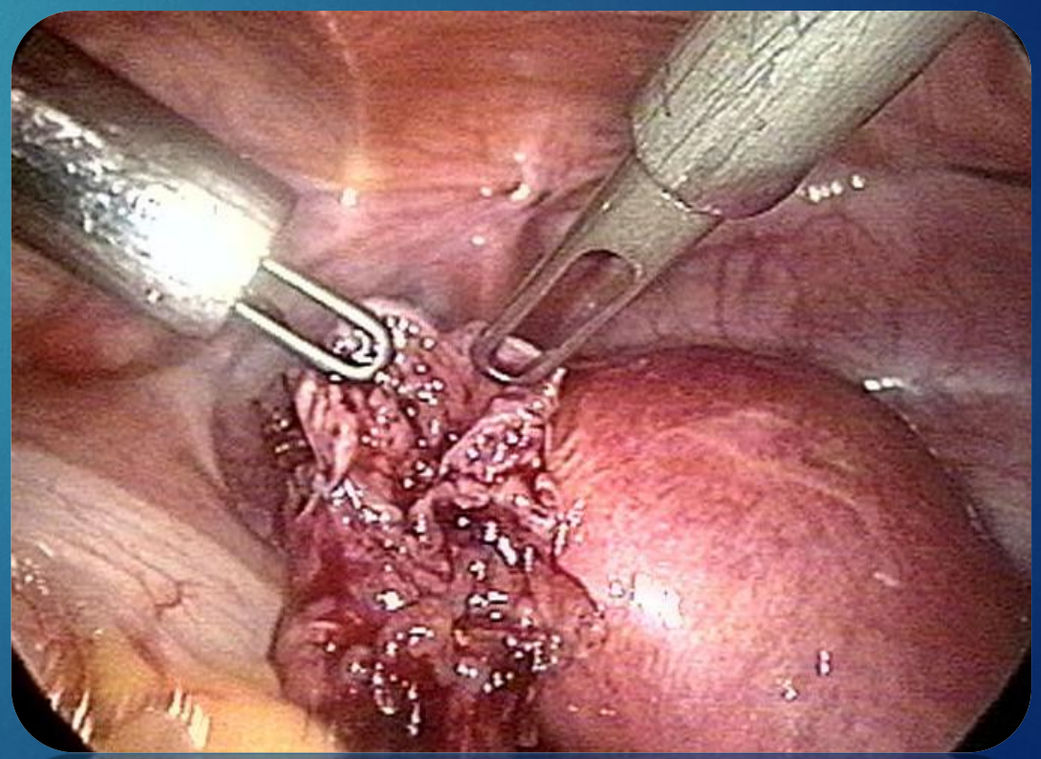
VI. CẬN LÂM SÀNG

5. Chọc dò Douglas

- Thống kê cho thấy khi có máu trong bụng thì chỉ 50% TNTC đã vỡ
- Hiện nay khynh hướng bảo tồn tai vòi nên chỉ định này ít còn sử dụng

6. Soi ổ bụng:

- Giúp chuẩn đoán xác định TNTC
- Có thể phẫu thuật: bảo tồn hoặc cắt bỏ VT.
- Đánh giá tình trạng viêm dính, bệnh lý TC và 2 PP, tiên lượng khả năng sinh sản.



VII. CHẨN ĐOÁN:

+ Chẩn đoán xác định: dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng (siêu âm và ßHCG) . Nội soi ổ bụng là tiêu chuẩn vàng.

+ Chẩn đoán phân biệt: sẩy thai, ứ dịch vòi TC, Vỡ nang hoàng thể/thai trong TC.



VIII. XỬ TRÍ

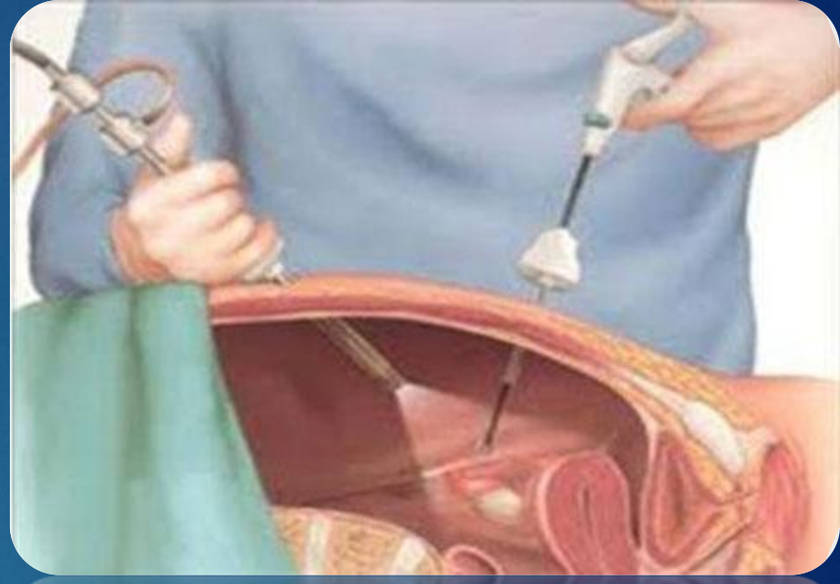
- Tuổi bệnh nhân
- Tiền sử & thai nghén
- Số con và nguyện vọng muốn có con hay không
- Đặc điểm, vị trí của khối TNTC
- Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân khi nhập viện
- Mục tiêu điều trị:

+ Duy trì khả năng sinh sản nếu cần

+ Cấp cứu kịp thời



VIII. ĐIỀU TRỊ:



1. Điều trị tận gốc:

- ***Cắt tai vòi sát góc TC: khi đủ con, TNTC vỡ, huyết tụ thành nang***
- ***Ưu tiên nội soi ổ bụng / mổ bụng khi tình trạng bệnh không thực hiện được NS)***
- ***Mổ lấy thai: nếu thai trong ổ bụng:***
  - ***+ Chết: mổ ngay để tránh rối loạn đông máu***
  - ***+ Sống: <24 tuần: mổ ngay***
  - ***> 24 tuần: chờ đến khi có khả năng nuôi được (32-36 tuàn) -> mổ lấy thai. Nhau nếu lấy được thì lấy, không lấy được để lại (MTX, tăc mạch -> đề phòng nhiễm trùng)***

VIII. ĐIỀU TRỊ:

1. Điều trị tận gốc:

- ***Thai ở đoạn kẽ → xẻ cơ TC / Xén góc TC***

- ***Thai ở cổ TC***

→ bảo tồn TC : MTX toàn thân hay tại chỗ để *

→ Có thể kết hợp Prostaglandin F2α giúp TC co thắt tống xuất thai và cầm máu

→ Cắt tử cung TH thai ≥ 12 tuần.



VIII. ĐIỀU TRỊ:

2. Điều trị bảo tồn: nếu còn muốn có con

- ***Chỉ định:***
  - ***huyết động học ổn định***
  - ***kích thước khối thai < 4cm , không có tim thai***
  - ***ßHCG ≤ 10 000 mIU/ml***



VIII. ĐIỀU TRỊ: cách điều trị tuỳ theo

2. Điều trị bảo tồn: nếu còn muốn có con

- ***Thuốc dùng:***

- MTX (methotrexate) 1mg/kg hoặc 1mg/m² da tiêm bắp

PHÁC ĐỒ ĐƠN LIỀU tiêm bắp N1

-Th eo dõi ßHCG N4 so N7 sau điều trị, nếu giảm 15% so với ban đầu thì theo dõi mỗi tuần cho đến khi âm tính.

- Nếu ßHCG tăng > = 15%-> lập lai liều điều trị lần 2, lần 3. Theo dõi, ßHCG 2 tuần/ lần đến khi âm tính

- Điều trị nội thất bại -> phẫu thuật.

PHÁC ĐỒ ĐA LIỀU tiêm bắp N1,N3, N5, N7 xen kẽ Leucoverin 0,1mg N2, N4, N6, N8 . Theo dõi ßHCG vào ngày chích mũi tiếp theo, nếu ßHCG giảm 15% thì theo dõi mỗi tuần cho đến khi âm tính

VIII. ĐIỀU TRỊ:

2. Điều trị bảo tồn: nếu còn muốn có con

•Phẫu thuật bảo tồn:

Xẻ vòi TC hút khối thai:

- Co mạch: Oxytocin trước xẻ

- Đề phòng sót nhau: theo dõi ßHCG, MTX sau mổ



IX. TIÊN LƯỢNG

- *Phát hiện sớm: tiên lượng tốt, có thể duy trì khả năng sinh sản*
- *Phát hiện trễ: TNTC đã vỡ, choáng: có thể nguy hiểm tính mạng (cuối Thế kỷ 19: tỉ lệ tử vong 5%. Hiện ngay dưới 5/10 000 , mặc dù tần suất bệnh tăng)*
- *Tái phát sau 1 lần bị TNTC : 10-25%*
- *Khả năng có thai trong TC ở người đã bị TNTC: 50-80%, số còn lại là vô sinh*



X. PHÒNG NGỪA

- *Quan hệ tình dục an toàn, chung thuỷ 1 vợ 1 chồng => tránh được bệnh lây truyền qua đường tình dục*
- *Điều trị triệt để cách viêm nhiễm đường sinh dục*
- *Giữ vệ sinh kinh nguyệt tốt*
- *Áp dụng tốt các biện pháp tránh thai -> tránh nạo hút thai*

